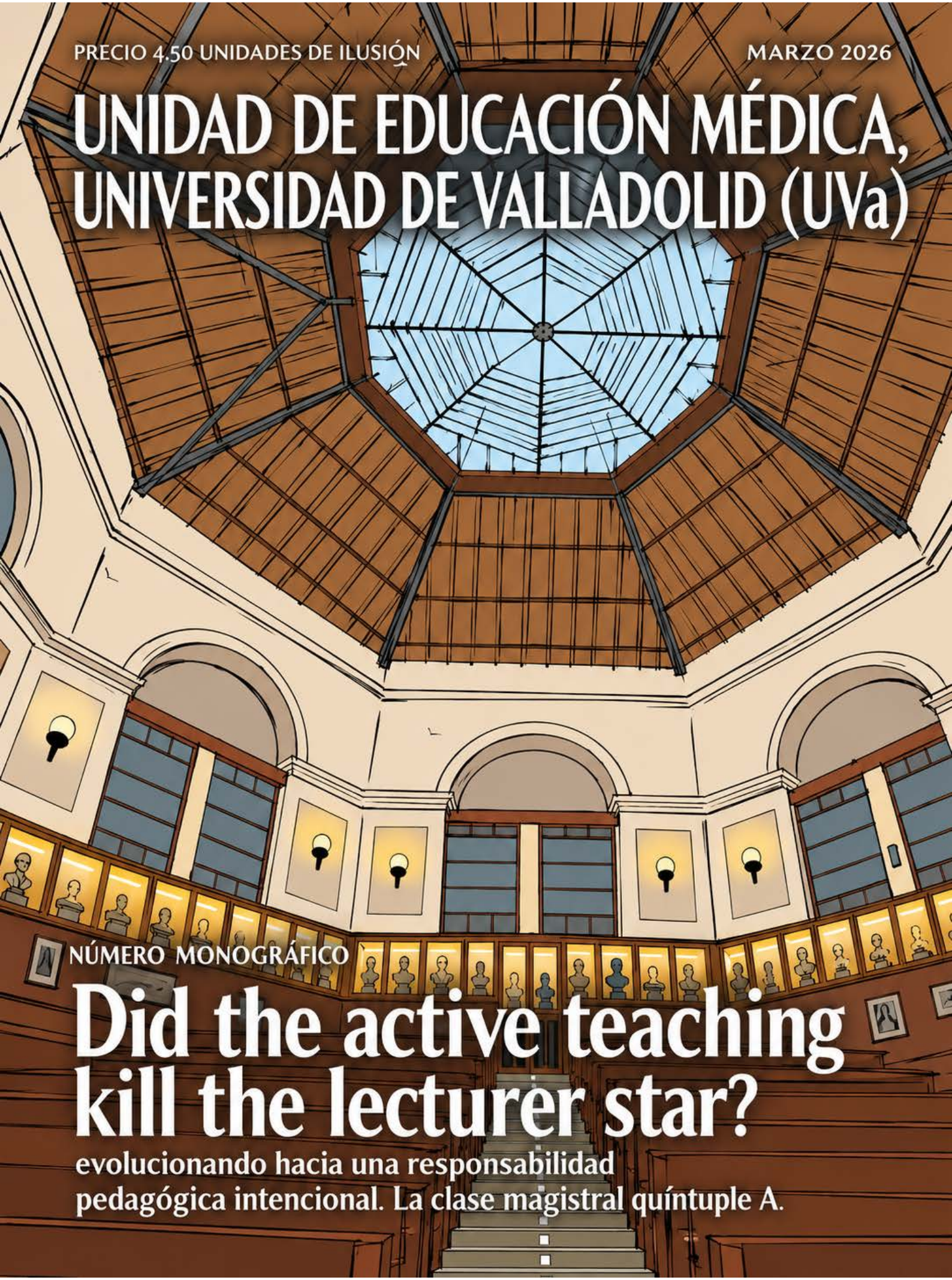
PRECIO 4.50 UNIDADES DE ILUSIÓN

MARZO 2026

UNIDAD DE EDUCACIÓN MÉDICA, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (UVa)



NÚMERO MONOGRÁFICO

Did the active teaching kill the lecturer star?

evolucionando hacia una responsabilidad pedagógica intencional. La clase magistral quíntuple A.

Did the active teaching kill the lecturer star?

Más allá del ruido que provoca el debate que enfrenta a la clase magistral y las metodologías activas

Durante décadas se ha transmitido la imagen de que la clase magistral era un modelo ya caduco, que nuevas tecnologías educativas como la clase invertida, el aprendizaje basado en problemas o casos clínicos, el aprendizaje autodirigido, el trabajo en grupos pequeños, el aprendizaje servicio, la simulacion, el peer-teaching o los debates entre otras, a las que agrupamos como activas en contraposición con la pasiva clase magistral, habían venido para sustituirla. La clase magistral quedaba ya como una reliquia del pleistoceno educativo.

Sin embargo, merece la pena hacerse algunas preguntas incómodas:

¿Y si toda esa literatura que supuestamente demostraba la superioridad abrumadora de las metodologías activas no fuera tan concluyente como nos dijeron? ¿Y si sus resultados dependieran más del entusiasmo del docente y del contexto específico que de la metodología en sí?

Si la clase magistral es tan ineficaz, ¿por qué sigue siendo la herramienta más utilizada por profesores de todo el mundo? ¿Es realmente solo inercia y pereza, o hay algo más?

¿Cómo explicamos que todos recordemos clases magistrales que nos fascinaron, que nos motivaron a estudiar, junto a sesiones presuntamente “activas” que fueron un auténtico bodrio?

¿Por qué tantas veces tenemos que incentivar con puntos a los estudiantes para que asistan a nuestras educativamente diseñadas aulas invertidas, mientras que esos mismos estudiantes madrugan voluntariamente para no perderse la clase de un profesor magistralmente ”pasivo”?

Quizás hemos errado el foco al pensar que lo importante era la metodología, que el tipo de herramienta docente elegida aseguraba el éxito educativo, y olvidábamos el papel de la técnica o habilidad del docente, su contexto y el de los alumnos.

Cuando un “mal profesor” acaba impartiendo una gran enseñanza

Esta aparente contradicción queda expuesta de forma magistral en el relato de John Dron titulado “*When good teachers do bad thing*”, recogido en su libro “*How Education Works* (2023)”[1].

En este relato, el autor introduce una anécdota que ilustra la disonancia. Un profesor que utilizaba prácticas consideradas metodológicamente deficientes, como clases magistrales presenciales, estrategias coercitivas de premios y castigos o evaluación exigente, resultó ser un docente excelente y premiado,

[1] Dron, J. (2023). *How education works: Teaching, technology, and technique*. Athabasca University Press.

reconocido por sus estudiantes y por la institución. Además del reconocimiento, el profesor conseguía que sus estudiantes fueran alumnos excelentes en las pruebas de desempeño. Dron concluye que la eficacia de su enseñanza no residía en el método utilizado, sino en la técnica docente. Este profesor demostraba un gran interés por los estudiante, mostraba pasión en el aula y hacia un seguimiento cercano del aprendizaje. Todo ello gracias a marcar una exigencia a los alumnos, pero con un apoyo y una presencia educativa que trascendía el aula.

Este ejemplo no es una anécdota aislada, sino que conecta con una evidencia cada vez más demostrada en educación médica. Por mucho que sus defensores describan sus ventajas, la implementación de metodologías activas como el aula invertida o el trabajo en grupo, por sí solos, no garantizan mejores resultados de aprendizaje que otras técnicas más "pasivas" y tiene un impacto bajo o moderado en los resultados en el mejor de los casos[2],[3]. En distintos estudios, se ha demostrado que su impacto es muy dependiente del contexto, del diseño concreto y, sobre todo, del docente que las aplica.

La tecnología educativa y las metodologías activas pueden facilitar el aprendizaje, pero no lo sustituyen. Estos métodos obtienen resultados subóptimos en manos de profesores inexpertos[4]. En general, la evidencia sugiere que el impacto educativo depende menos del método empleado y más de la calidad de la enseñanza, especialmente de la claridad docente y la retroalimentación efectivas[5].

Por tanto y partiendo desde este enfoque, la pregunta no es si la clase magistral ha sido "superada", sino si hemos sobreestimado el poder teórico de los distintos método docentes y subestimado el peso de la técnica personal de cada docente. En educación médica, donde el razonamiento clínico, la integración conceptual y la toma de decisiones complejas son centrales, el formato expositivo sigue teniendo un papel potencial, si se consigue que esté bien diseñado e implementado.

Limitaciones inherentes a la clase magistral

Esta claro que si a un ladrillo le afinamos los cantos o le ponemos alas de cartón y timón de cola, le mejoramos la aerodinámica. Pero por mucho que insistamos, no podremos hacerle volar como a un avión. Las clase magistral tiene varias limitaciones inherentes a su diseño que no podemos obviar.

Limitación	Descripción
Flujo unidireccional	La información va del docente al estudiante, muchas veces sin retroalimentación efectiva
Fomenta la pasividad	Promueve que el estudiante adopte un rol receptor en vez de ser un participante activo
Aprendizaje superficial	Promueve la memorización sobre el procesamiento profundo
Adaptación limitada	Puede adaptarse al grupo en general, pero no a cada estudiante individual. Esto puede dar lugar a que determinados alumnos se queden atrás.

[2] Naing C, Whittaker MA, Aung HH, Chellappan DK, Riegelman A. The effects of flipped classrooms to improve learning outcomes in undergraduate health professional education: A systematic review. Campbell Syst Rev. 2023 Jul 7;19(3):e1339. doi: 10.1002/cl2.1339.

[3] Chen F, Lui AM, Martinelli SM. A systematic review of the effectiveness of flipped classrooms in medical education. Med Educ. 2017 Jun;51(6):585-597. doi: 10.1111/medu.13272.

[4] Malhotra AS, Bhagat A. Flipped classroom for undergraduate medical students in India: are we ready for it? Adv Physiol Educ. 2023;47:694-698. doi: 10.1152/advan.00200.2022.

[5] Hattie, J. Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Routledge; 2008.

Dependiente del docente	Su desarrollo está muy influido por el estado de ánimo e inspiración del profesor
Rigidez temporo-espacial	El reloj y el aula marcan el ritmo y limitan el desarrollo

Estas limitaciones hacen que, aunque mejoremos la dinámica de la clase y la "activemos" como veremos en el siguiente punto, la clase magistral no pueda ser utilizada como la única estrategia docente. La clase magistral puede funcionar como una herramienta más dentro del ecosistema de recursos docentes que utilizan profesores y alumnos.

Además de estas limitaciones propias del modelo, también existen riesgos y costes de oportunidad si nos empeñamos en utilizar las clases magistrales como formato docente predominante. No se trata solo de lo que no se consigue con una clase magistral clásica, sino de las habilidades que se ven bloqueadas en su desarrollo cuando la clase magistral se presenta en su versión más pasiva. En las clases magistrales no es fácil conseguir un desarrollo del pensamiento crítico, no se fomenta la resolución autónoma de problemas, ni la colaboración entre pares, ni la capacidad de autorregulación del aprendizaje.

El desarrollo de nuestros estudiantes no se limita a cuánto "llenamos" su memoria. Si nuestra meta es formar profesionales autónomos, capaces de aprender de forma continua a lo largo de toda su carrera profesional, ¿no estamos generando dependencia del '"sabio desde el estrado" cuando la clase magistral es nuestra estrategia principal? ¿No estamos enviando el mensaje implícito de que el conocimiento válido es solo el que transmite el experto, inhibiendo así la curiosidad, la búsqueda independiente y la confianza en su propio juicio clínico? ¿No les estamos privando, precisamente, de las oportunidades para desarrollar las competencias que más necesitarán cuando nosotros ya no estemos delante?

El uso "monográfico de la clase magistral como método único o predominante puede acabar generando exactamente lo contrario de lo que pretendemos. Profesionales competentes en reproducir conocimiento ajeno, pero inseguros al momento de generarlo, cuestionarlo o aplicarlo de forma independiente.

¿Cuáles son los aspectos que podemos mejorar?

Aceptar que la clase magistral no está necesariamente superada y que podemos seguir utilizándola, no implica defender su forma más pobre, en la que hay una exposición unidireccional, cerrada y centrada en la transmisión de datos. Ese modelo, cuando se utiliza de manera sistemática, presenta limitaciones muy marcadas.

La cuestión relevante es otra. ¿Puede el docente imprimir su sello, su técnica y su intención educativa en una clase magistral? La respuesta es que sí. La clase magistral no debe ser un objeto monolítico e inalterable en el que se cuenta una presentación, sino que es un formato que puede ser transformado. Existen distintas estrategias para hacerla más personal y participativa sin renunciar a su función de estructuración del conocimiento:

- Disminuir la carga cognitiva de la materia (principios del aprendizaje multimedia).
- Activar cognitivamente al estudiante mediante preguntas relevantes.
- Adaptar el ritmo y la profundidad de la la clase al grupo de alumnos.

• Introducir cambios de ritmo durante la clase, con distintas actividades, con pausas cada 10-15 minutos para hablar o pensar.

• Orientar el temario en secciones, que se enfoquen en responder a preguntas y no a nominar temas *(En vez de una clase sobre el temido "ciclo de Krebs", una clase sobre "¿Cómo utilizan mis células los nutrientes?"*)

• Crear espacios para la discusión como el piensa-comparte con tu compañero-comparte con la clase (Think-pair-share). Para esta última parte podemos aprovechar las tecnologías para la interacción.

• Orientar la exposición a problemas reales, no a listas de datos.

• Preguntar al final de la clase *¿Qué no se entendió? ¿Cuál fue la idea clave?* Para esto también podemos aprovechar las tecnologías para la interacción.

• Permitir que la clase sea auténtica, abierta a la interacción y a la reformulación.

• Invitar a otros "protagonistas" además del profesor (pacientes, otros profesionales, otros profesores)

• Integrarla en un ecosistema docente más completo, no siendo el único recurso formativo por utilizar.

• Extender el aprendizaje más allá del tiempo presencial (en el campus electrónico, en el correo, en las redes).

• Ser conscientes del valor de la gestualidad. No esconderse detrás de la mesa o el atril, salir al aula. Señalar con la mano abierta al invitar a participar frente a señalar con el dedo,...

Desde esta perspectiva, la disyuntiva no es "clase magistral o innovación", sino **clase magistral acrítica y pasiva** frente a **clase magistral intencionalmente diseñada**, integrada en un ecosistema educativo más amplio. Un ecosistema en el que la exposición estructurada convive con metodologías activas, evitando concentrar toda la docencia en un único enfoque pedagógico.

El papel de la tecnología y sobre todo de la tecnología enfocada a la interacción en el aula (Wooclap, Kahoot, Ahaslides,...) es aquí clave, ya que la transformación de la clase magistral en aprendizaje activo es lo que le da un propósito al uso de esta tecnología.

> "La pregunta no es si debemos abandonar la clase magistral, sino si estamos dispuestos a asumir la responsabilidad pedagógica que implica seguir utilizándola"

La clase magistral quíntuple A

¿Por qué conformarse con una clase magistral convencional si podemos transformarla en una clase con máxima valoración académica?

Aún asumiendo las limitaciones, una clase magistral puede convertirse en una experiencia más productiva si tenemos en cuenta estas 5 características (5Aes)

Característica de la clase magistral	Descripción
Activas y abiertas	Abiertas a la participación, promoviendo activación cognitiva mediante preguntas relevantes, decisiones breves y participación del alumnado.

Ágiles y adaptadas	Adaptadas al ritmo de la clase, con segmentación, cambios de ritmo y una gestión consciente de la carga cognitiva.
Aplicables	Orientadas a problemas y marcos conceptuales propios del "pensar médico", y no a la transmisión de listas de hechos o datos.
Auténticas	Basadas en la *presencia* intelectual del docente, donde cada clase es única y no completamente reproducible.
Ampliables	Entendidas como un punto de partida que se prolonga más allá del aula mediante infografías, campus virtual, interacción, redes sociales, foros de debate o tareas de investigación o preguntas semilla.

¿Cuál es el lugar de la clase magistral en el aula del siglo XXI?

Aunque esta visión de clase magistral puede hacer que su valor educativo mejore, no podemos engañarnos. Sigue teniendo un valor limitado. Necesitamos las herramientas docentes activas para conseguir objetivos docentes como aplicar el conocimiento, analizar, evaluar o crear (los cuatro últimos órdenes de la taxonomía revisada de Bloom). La clase magistral es solo una herramienta más, no el sol de la enseñanza en torno al cual giran como complementos o micro intervenciones las herramientas docentes activas.

Algunas de las actividades donde la clase magistral tiene un claro valor son:

Acción	Descripción
Inspirar	Cuando el foco no es tanto el conocimiento sino motivar. Transmitir pasión, vocación y la dimensión humana de la medicina
Introducir conceptos	Diseminación inicial de información a audiencias grandes. Presentar un tema nuevo, crear un mapa mental común antes de profundizar
Sintetizar	Integración de conocimientos dispersos que serían difíciles de conectar para no expertos
Modelar	Demostración de razonamiento experto. Pensar en voz alta sobre un caso complejo, mostrar cómo un experto aborda la incertidumbre
Recursos y tiempo escasos	Cuando no hay tiempo ni recursos. Mejor una buena clase magistral que una mala metodología activa mal implementada

Pero, si yo me pongo a "mejorar" mis clases ¿Quién da el programa?

Si aún no eres consciente de ello, ahora ya podemos aclarar que tus temores son acertados. No puedes dar todo tu programa en clases presenciales.

Para conseguir unas clases magistrales de calidad hay que focalizarse en ideas claves y asegurarse de que estas se entienden. El resto del temario, las listas interminables de hechos o datos que sea necesario aprender o conceptos menos importantes estarán en el material del curso y podrán ser materia para evaluar. Pero no podemos sacrificar los 50 minutos de interacción del profesor y sus alumnos en recitar información que está en los libros. Esos 50 minutos son oro. Son la oportunidad para transmitir qué es lo verdaderamente importante de la asignatura. Es el tiempo para contagiar el entusiasmo por la disciplina y expresar que nos apasiona del temario. Es el lugar para compartir las anécdotas que dan sentido a los conceptos y, sobre todo, mostrar la humanidad que hay detrás de ser médico. Esas partes que no están en ningún manual y que ninguna inteligencia artificial les puede mostrar.

"Pretender abordar la totalidad del programa de una asignatura del Grado en Medicina exclusivamente mediante metodologías activas resulta, en la práctica, inviable. Del mismo modo, recurrir a clases magistrales aceleradas, centradas en la lectura o enumeración de contenidos, carece de valor educativo.

Una última reflexión

A lo largo de todo este documento hemos venido valorando la clase magistral y su evolución hacia un formato más participativo como una responsabilidad propia de los profesores. Pero ¿cuál es el papel de los estudiantes en el siglo XXI? ¿Con la llegada de la inteligencia artificial, el acceso universal y ubicuo a la información y todo lo que hemos aprendido sobre metodología educativa, no es hora ya de que redefinan su papel?

¿Deben dejar de ser receptores pasivos de información y cumplimentadores de test para convertirse en co-responsables de su propio aprendizaje? La respuesta parece obvia, pero implica un cambio cultural profundo.

Un estudiante co-responsable de su aprendizaje debería:

- Llegar a clase habiendo reflexionado sobre el material previo, no solo para escuchar por primera vez conceptos que podría haber leído.
- Participar activamente en la construcción de su conocimiento, no espera a que se lo entreguen empaquetado.
- Buscar retroalimentación para mejorar, no solo calificaciones para aprobar.
- Identificar sus propias lagunas y trabaja para llenarlas, sin esperar que cada detalle le sea explicitado.
- Entender que su formación no es una carrera de obstáculos hacia un título, sino el inicio de un compromiso de aprendizaje que durará toda su vida profesional.

Sin embargo, este cambio de rol no puede exigirse sin transformar simultáneamente el entorno educativo. Los estudiantes adoptarán esta nueva actitud solo si el sistema la valora, la facilita y la recompensa. Esto significa que los docentes debemos estar dispuestos a diseñar experiencias de aprendizaje que requieran participación, a evaluar competencias más allá de la memorización, y a crear una cultura donde hacerse preguntas sea tan valorado como dar respuestas, o incluso más.

Y en el ecosistema educativo necesario para alcanzar estos objetivos, las clases magistrales "activadas" también tienen su papel.

Referencias útiles

Mejorar las clases magistrales

https://teaching.unl.edu/resources/interactive-lecture/

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01421590120043000

Aprendizaje multimedia

https://tutorcyllo.wixsite.com/educacionmedicauva/post/edumed-aprendizaje-multimedia-en-eduación-superior-base-teóricas

https://tutorcyllo.wixsite.com/educacionmedicauva/post/edumed-aprendizaje-multimedia-en-eduación-superior-principios-para-mejorar-nuestra-enseñanza

https://tutorcyllo.wixsite.com/educacionmedicauva/post/funcionan-educativamente-los-microvideos-y-los-podcasts

https://tutorcyllo.wixsite.com/educacionmedicauva/post/edumed-el-poder-de-las-infografías-en-la-educación

Anexo I.

Tabla de principios para una clase magistral intencional en educación médica

Principio	Que implica en la práctica	Ejemplos posibles en el aula
Activación cognitiva	El estudiante procesa activamente la información: interpreta, decide y explica.	• Hacer preguntas clínicas breves • Pedir que justifiquen decisiones • Identificar errores frecuentes y debatirlos.
Adaptación al grupo de alumnos	El ritmo y la profundidad se ajustan al nivel y respuesta del alumnado.	• Reducir o ampliar contenidos según las dudas que se generan • Reformular explicaciones en tiempo real. • Buscar oportunidades para la retroalimentación.
Cambios de ritmo y formato	Variación intencional de estímulos para sostener la atención.	• Alternar explicación con imágenes clínicas, vídeos cortos, cuestionarios, debates breves o realización de actividades en la clase • Incluir pausas cada 15 minutos
Orientación a problemas y marcos conceptuales	El foco está en preguntas relevantes y en el razonamiento médico.	• Estructurar la clase en torno a conceptos, criterios diagnósticos o decisiones clínicas, evitando listas exhaustivas de datos. Usar casos clínicos y problemas concretos como punto de partida • Presentar algoritmos de decisión o marcos de razonamiento o priorización • Plantear dilemas que requieran sopesar evidencia y contextualizar decisiones
Autenticidad docente	La clase no es completamente reproducible; el docente piensa con el grupo.	• Modificar el recorrido según preguntas • Integrar experiencias clínicas reales.
Participación de otros actores	Incorporación de dimensiones humanas y profesionales más allá del docente.	• Participación de pacientes • Intervención de otros profesionales sanitarios y profesores.
Integración en un ecosistema docente	La clase magistral es una pieza más del diseño curricular.	• Combinación con herramientas más activas: seminarios, prácticas, aula invertida, resolución de problemas, trabajo en grupo, estudio autónomo.
Ampliación más allá del aula	La clase se prolonga en profundidad e interacción tras el tiempo presencial.	• Infografías en campus virtual; foros de debate; preguntas abiertas post-clase, uso de las redes sociales, propuesta de actividades en grupo o individuales basadas en lo expuesto en la clase.
***Coherencia con evaluación**	Alineación entre lo enfatizado en clase y lo evaluado.	• Utilizar en la evaluación preguntas centradas en razonamiento y conceptos clave, no en recuerdo literal.